

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA VALUTAZIONE E GESTIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO010_00	00	12/04/2026	9
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSPP / MC	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. Fattori di rischio specifici del settore diagnostico.....	4
5. Metodologia di valutazione.....	4
5.1 Valutazione preliminare (fase obbligatoria).....	4
5.2 Valutazione approfondita (fase eventuale).....	4
6. Gruppi omogenei di lavoratori.....	5
7. Indicatori oggettivi (eventi sentinella e dati aziendali).....	5
8. Fattori di contenuto del lavoro.....	6
9. Fattori di contesto del lavoro.....	6
10. Esito della valutazione e livelli di rischio.....	6
11. Misure correttive e preventive.....	7
11.1 Interventi organizzativi.....	7
11.2 Interventi sulla persona.....	7
12. Sorveglianza sanitaria.....	7
13. Ruolo del Medico Competente.....	8
14. Integrazione con i sistemi di gestione sociale.....	8
15. Formazione e sensibilizzazione.....	8
16. Monitoraggio e aggiornamento.....	8
17. Matrice delle responsabilità (RACI).....	9
18. Indicatori di processo.....	9
19. Storico delle revisioni.....	9

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina la valutazione e la gestione del rischio da stress lavoro-correlato (SLC) in tutte le strutture della rete Toscana Diagnostica, in conformità all'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, che include espressamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi oggetto di valutazione obbligatoria, e all'art. 28, comma 1-bis, che richiama le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente.

La procedura si applica a tutte le sedi operative e a tutti i lavoratori, con particolare attenzione ai gruppi omogenei esposti a fattori di rischio psicosociale specifici del settore diagnostico sanitario. Il perimetro comprende le strutture acquisite, che sono integrate nel processo di valutazione entro 12 mesi dal closing.

Lo stress lavoro-correlato non è una malattia, ma una condizione che, se prolungata, può ridurre l'efficienza lavorativa, aumentare gli errori diagnostici, compromettere la qualità delle relazioni con i pazienti e generare sofferenza nelle persone. Prevenirlo è un investimento nella qualità, nella sicurezza e nel benessere dell'organizzazione.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
D.Lgs. 81/2008, art. 28 c. 1 e 1-bis	Obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato
Accordo Europeo 8/10/2004	Accordo quadro sullo stress nei luoghi di lavoro (recepito dall'Accordo Interconfederale 9/06/2008)
Circolare Min. Lavoro 18/11/2010	Indicazioni per la valutazione del rischio SLC (Commissione Consultiva Permanente)
INAIL – Metodologia 2017	La metodologia per la valutazione e gestione del rischio SLC (manuale INAIL aggiornato)
ISO 45001:2018, cl. 6.1.2	Identificazione dei pericoli: fattori psicosociali e organizzativi
ISO 45003:2021	Gestione della salute e sicurezza psicologica sul lavoro
PAS 24000:2022, cl. A.3	Condizioni di lavoro: orario, carico, benessere organizzativo
UNI PdR 125:2022	Parità di genere: conciliazione vita-lavoro, tutela della genitorialità
ISO 7101:2023	Qualità sanitaria: benessere del personale e sicurezza del paziente
TD-SGI-POL001	Politica Integrata del SGI
TD-SGI-PLN002	Piano Strategico Parità di Genere, D&I

3. Termini e definizioni

Stress lavoro-correlato (SLC): condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro (Accordo Europeo 8/10/2004).

Fattori di contenuto del lavoro: elementi intrinseci all'attività lavorativa che possono generare stress: carico e ritmi di lavoro, orario, turni, autonomia decisionale, monotonia, complessità delle mansioni.

Fattori di contesto del lavoro: elementi relativi all'organizzazione e alle relazioni: ruolo, carriera, comunicazione, leadership, partecipazione, relazioni interpersonali, interfaccia casa-lavoro.

Eventi sentinella: indicatori oggettivi di possibile presenza di stress: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, reclami, procedimenti disciplinari, segnalazioni, richieste di trasferimento.

Gruppo omogeneo: insieme di lavoratori accomunati da medesime condizioni di esposizione ai fattori di rischio psicosociale (stessa mansione, stesso reparto, stesse condizioni organizzative).

Valutazione preliminare: fase obbligatoria della valutazione SLC, basata su indicatori oggettivi e sulla rilevazione dei fattori di contenuto e contesto del lavoro.

Valutazione approfondita: fase eventuale, attivata quando la valutazione preliminare evidenzia un rischio non basso, basata sulla percezione soggettiva dei lavoratori (questionari, focus group, interviste).

4. Fattori di rischio specifici del settore diagnostico

Il settore della diagnostica di laboratorio e per immagini presenta fattori di rischio psicosociale peculiari che richiedono una valutazione mirata:

Fattore specifico	Descrizione e impatto
Responsabilità diagnostica	L'errore analitico o interpretativo può avere conseguenze dirette sulla salute del paziente. La consapevolezza di questa responsabilità genera un carico psicologico strutturale
Ritmi e tempi di refertazione	La pressione sui tempi di risposta (refertazione entro 24h, urgenze) e i picchi di lavoro stagionali creano tensione organizzativa
Esposizione a rischio biologico	La consapevolezza del rischio di infezione (HBV, HCV, HIV, TBC) è un fattore di stress cronico, amplificato dopo l'esperienza pandemica COVID-19
Lavoro su turni	I turni, inclusi quelli notturni e festivi nel Laboratorio centralizzato, alterano i ritmi circadiani e interferiscono con la vita sociale e familiare
Rapporto con il paziente ansioso	Il contatto con pazienti in stato di ansia, paura o sofferenza (attesa di referti oncologici, diagnosi incerte) è emotivamente gravoso
Isolamento nei punti prelievo periferici	Il personale dei punti prelievo periferici opera spesso in autonomia, con limitato supporto immediato dei colleghi
Integrazione post-acquisizione	L'ingresso nella rete TD di strutture precedentemente autonome genera incertezza su ruoli, procedure e identità professionale
Carico tecnologico	L'aggiornamento continuo di sistemi informativi (LIS, RIS, PACS), procedure e apparecchiature richiede adattamento costante

5. Metodologia di valutazione

La valutazione del rischio SLC segue la metodologia INAIL 2017, conforme alle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente (Circolare Min. Lavoro 18/11/2010), articolata in due fasi.

5.1 Valutazione preliminare (fase obbligatoria)

La valutazione preliminare è condotta dal Gruppo di Gestione della Valutazione, composto da: RSPP (coordinatore), Medico Competente, People & Culture Manager, RSGI, un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il Gruppo analizza tre famiglie di indicatori: gli eventi sentinella (Sezione 7), i fattori di contenuto del lavoro (Sezione 8) e i fattori di contesto del lavoro (Sezione 9). Per ciascun gruppo omogeneo, i fattori sono valutati con la checklist INAIL e classificati in tre livelli di rischio: basso (verde), medio (giallo), alto (rosso).

Se la valutazione preliminare evidenzia un livello di rischio basso per tutti i gruppi omogenei, il risultato è documentato nel DVR e la valutazione è aggiornata con cadenza biennale o in occasione di modifiche organizzative significative. Se il livello è medio o alto, si attivano le misure correttive (Sezione 11) e, se queste non producono miglioramento entro 12 mesi, si procede alla valutazione approfondita.

5.2 Valutazione approfondita (fase eventuale)

La valutazione approfondita rileva la percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti validati: questionari standardizzati (HSE Management Standards Indicator Tool o equivalenti validati in italiano), distribuiti in forma anonima a tutti i lavoratori del gruppo omogeneo interessato, con tasso di risposta minimo del 70% per la validità dei risultati; focus group condotti da un facilitatore esterno qualificato, con gruppi di 6-10 lavoratori selezionati per rappresentatività; colloqui individuali su base volontaria con il Medico Competente o con uno psicologo del lavoro. I risultati della valutazione

approfondita sono analizzati dal Gruppo di Gestione e integrati nel DVR con il piano delle azioni correttive specifiche.

6. Gruppi omogenei di lavoratori

Ai fini della valutazione SLC, i lavoratori di Toscana Diagnostica sono suddivisi nei seguenti gruppi omogenei, definiti in base alla mansione, alle condizioni organizzative e al livello di esposizione ai fattori di rischio psicosociale:

N.	Gruppo omogeneo	Mansioni incluse	Fattori di rischio prevalenti
1	Laboratorio – Tecnici e biologi	TSLB, biologi, tecnici preanalitico, addetti catene analitiche	Responsabilità diagnostica, ritmi, rischio biologico, turni
2	Laboratorio – Microbiologia	TSLB microbiologia, biologi microbiologia	Rischio biologico elevato, concentrazione, responsabilità diagnostica
3	Punti prelievo – Infermieri/TSLB	Infermieri e TSLB nei punti prelievo della rete	Paziente ansioso, isolamento, ritmi, rischio biologico
4	Diagnostica per immagini	TSRM, medici radiologi, personale di sala	Responsabilità diagnostica, carico tecnologico, turni, radiazioni
5	Accettazione e front office	Addetti accettazione, CUP, front office	Rapporto con paziente, ritmi, carico emotivo, reclami
6	Direzione e funzioni centrali	AD, manager, staff centrale	Carico decisionale, multitasking, interfaccia casa-lavoro
7	Personale strutture acquisite	Tutti i ruoli nelle strutture neo-acquisite	Integrazione post-acquisizione, incertezza, cambiamento procedure

7. Indicatori oggettivi (eventi sentinella e dati aziendali)

Gli eventi sentinella sono indicatori oggettivi che segnalano possibili condizioni di stress organizzativo. Sono rilevati per ciascun gruppo omogeneo con cadenza annuale:

Indicatore	Fonte dati	Cadenza	Soglia di attenzione
Indice infortunistico (IF)	Registro infortuni, INAIL	Annuale	Aumento >20% vs anno precedente
Assenze per malattia (giornate/dipendente)	HR, rilevazione presenze	Semestrale	Aumento >20% vs media aziendale
Turnover volontario	HR, cessazioni	Annuale	>15% annuo nel gruppo omogeneo
Richieste di trasferimento	HR	Annuale	Concentrazione in un gruppo omogeneo
Procedimenti disciplinari	HR, CO	Annuale	Aumento significativo
Reclami dei lavoratori	HR, P&C, canale whistleblowing	Continuo	Ripetitività su temi organizzativi
Segnalazioni di disagio / molestie	P&C, Delegata PO, CO	Continuo	Qualsiasi segnalazione
Visite straordinarie su richiesta del lavoratore	MC	Annuale	Concentrazione in un gruppo omogeneo

8. Fattori di contenuto del lavoro

I fattori di contenuto del lavoro sono valutati per ciascun gruppo omogeneo attraverso la checklist INAIL. Comprendono:

- Ambiente di lavoro e attrezzature: adeguatezza degli spazi, condizioni microclimatiche, rumore, illuminazione, ergonomia delle postazioni, stato delle apparecchiature diagnostiche, disponibilità di DPI.
- Pianificazione dei compiti: chiarezza delle mansioni, prevedibilità delle attività, varietà dei compiti, monotonia o frammentarietà, significatività del lavoro, possibilità di utilizzare le proprie competenze.
- Carico e ritmi di lavoro: quantità di lavoro in rapporto al tempo disponibile, picchi e distribuzione del carico, pressione sui tempi (refertazione, urgenze), sovraccarico o sottocarico, possibilità di pause adeguate.
- Orario di lavoro: durata dell'orario effettivo, lavoro straordinario, turni, lavoro notturno e festivo, flessibilità oraria, prevedibilità dei turni, tempo di preavviso per variazioni, diritto alla disconnessione.

9. Fattori di contesto del lavoro

I fattori di contesto del lavoro sono valutati con la medesima checklist e comprendono:

- Funzione e cultura organizzativa: chiarezza degli obiettivi aziendali, comunicazione interna, coerenza tra valori dichiarati e pratiche effettive, gestione del cambiamento (acquisizioni, riorganizzazioni), equità percepita.
- Ruolo nell'organizzazione: chiarezza del ruolo e delle responsabilità, ambiguità o conflitto di ruolo, adeguatezza delle deleghe, corrispondenza tra competenze richieste e competenze possedute.
- Evoluzione della carriera: prospettive di crescita professionale, criteri di promozione, riconoscimento del merito, sicurezza del posto di lavoro, equità di trattamento.
- Autonomia decisionale e controllo: grado di autonomia nello svolgimento dei compiti, possibilità di influenzare le modalità di lavoro, partecipazione ai processi decisionali, micromanagement.
- Relazioni interpersonali: qualità dei rapporti con superiori, colleghi e collaboratori, supporto sociale, presenza di conflitti, isolamento, molestie, discriminazioni.
- Interfaccia casa-lavoro: conciliazione vita-lavoro, supporto per la genitorialità, flessibilità, rispetto dei tempi personali, carico emotivo portato a casa.

10. Esito della valutazione e livelli di rischio

L'esito della valutazione preliminare classifica ciascun gruppo omogeneo in tre livelli di rischio:

Livello	Descrizione e azione
BASSO (verde)	La valutazione non evidenzia condizioni di rischio SLC significative. Il risultato è documentato nel DVR. Monitoraggio biennale. Nessuna azione correttiva immediata richiesta, ma si mantengono le misure preventive in atto.
MEDIO (giallo)	La valutazione evidenzia condizioni che possono determinare rischio SLC. Si adottano azioni correttive organizzative mirate (Sezione 11). Si rivaluta entro 12 mesi. Se le azioni non producono miglioramento, si attiva la valutazione approfondita.
ALTO (rosso)	La valutazione evidenzia una condizione di rischio SLC elevato. Si attivano immediatamente azioni correttive organizzative e sulla persona (Sezione 11). Si attiva la valutazione approfondita. Si intensifica la sorveglianza sanitaria. Si rivaluta entro 6 mesi.

11. Misure correttive e preventive

11.1 Interventi organizzativi

Gli interventi organizzativi agiscono sulle cause dello stress e sono prioritari rispetto agli interventi sulla persona:

- Revisione dei carichi di lavoro e dei ritmi: ridistribuzione dei compiti, potenziamento degli organici nelle aree critiche, revisione dei turni con criteri di equità e prevedibilità, garanzia di pause adeguate.
- Chiarificazione di ruoli e responsabilità: aggiornamento delle job description, definizione chiara delle deleghe, riduzione dell'ambiguità di ruolo, coerenza tra responsabilità e autonomia.
- Miglioramento della comunicazione interna: riunioni periodiche di reparto, feedback strutturato, comunicazione trasparente sul cambiamento organizzativo (acquisizioni, riorganizzazioni), ascolto attivo.
- Promozione della conciliazione vita-lavoro: flessibilità oraria ove compatibile, smart working per le funzioni amministrative, rispetto del diritto alla disconnessione, supporto alla genitorialità (TD-SGI-PLN002).
- Rafforzamento del supporto sociale: mentoring per i nuovi inserimenti, team building, valorizzazione del lavoro di squadra, programmi di accoglienza per il personale delle strutture acquisite.
- Formazione dei responsabili: sviluppo delle competenze di leadership relazionale, gestione dei conflitti, riconoscimento dei segnali di disagio, comunicazione efficace.

11.2 Interventi sulla persona

Gli interventi sulla persona sono complementari a quelli organizzativi e sono attivati in parallelo nei casi di rischio alto o su richiesta del lavoratore:

- Sportello di ascolto psicologico: accesso gratuito e riservato a un servizio di supporto psicologico, erogato da professionisti esterni qualificati, disponibile per tutti i lavoratori senza necessità di autorizzazione del responsabile.
- Programmi di gestione dello stress: tecniche di coping, mindfulness, gestione del tempo, rilassamento, offerti nell'ambito del piano formativo annuale.
- Supporto al reinserimento: percorsi di accompagnamento per il rientro dopo assenze prolungate (malattia, maternità, burnout), con colloquio di rientro strutturato e piano di reinserimento graduale.
- Sorveglianza sanitaria mirata: visite straordinarie su richiesta del lavoratore o su segnalazione del responsabile, con valutazione psicologica e, se necessario, invio a specialista.

12. Sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente integra la valutazione del rischio SLC nel protocollo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. In sede di visita medica periodica, il MC valuta i segnali di disagio psicologico e verifica l'eventuale correlazione con le condizioni lavorative. Il MC può proporre idoneità condizionate (ad esempio, limitazione del lavoro notturno, riduzione temporanea del carico) o prescrizioni specifiche volte a tutelare la salute del lavoratore. Le visite straordinarie su richiesta del lavoratore (art. 41, comma 1, lett. c) sono garantite senza ritardi e gestite con la massima riservatezza. Il MC partecipa al Gruppo di Gestione della Valutazione e fornisce la propria competenza medica nella lettura degli eventi sentinella e nella definizione delle misure correttive.

13. Ruolo del Medico Competente

Il Medico Competente svolge un ruolo centrale nella gestione del rischio SLC: collabora alla valutazione preliminare e approfondita come membro del Gruppo di Gestione; rileva i segnali precoci di disagio psicologico durante le visite periodiche; gestisce le visite straordinarie su richiesta del lavoratore; formula giudizi di idoneità con eventuali prescrizioni o limitazioni; orienta il lavoratore verso servizi di supporto psicologico o specialistico quando necessario; contribuisce alla relazione sanitaria annuale, con sezione dedicata al rischio SLC, nel rispetto della privacy individuale e con dati aggregati e anonimi; segnala al RSPP e alla Direzione le situazioni di criticità emergenti, senza rivelare dati sanitari individuali.

14. Integrazione con i sistemi di gestione sociale

La valutazione e la gestione del rischio SLC sono integrate con i sistemi di gestione sociale adottati da Toscana Diagnostica. La ISO 45003:2021 (salute e sicurezza psicologica sul lavoro) fornisce il framework di riferimento per l'identificazione dei rischi psicosociali e per la progettazione degli interventi. La PAS 24000:2022 (gestione sociale) richiede il monitoraggio delle condizioni di lavoro, dell'orario, del carico e del benessere organizzativo. La UNI PdR 125:2022 e la ISO 30415:2021 alimentano la valutazione con i dati sulla parità di genere, sulla conciliazione vita-lavoro e sull'inclusione, in quanto le discriminazioni e le difficoltà di conciliazione sono fattori di rischio SLC riconosciuti. I risultati della valutazione SLC sono input per il Comitato Guida PdG e D&I (TD-SGI-REG001) e per il Report di Sostenibilità (TD-SGI-PLN003).

15. Formazione e sensibilizzazione

La formazione sul rischio SLC è articolata come segue:

- Informazione generale a tutti i lavoratori (1 ora, nell'ambito dell'induction): cos'è lo stress lavoro-correlato, i segnali precoci, i canali di supporto disponibili, il ruolo del MC.
- Formazione ai responsabili e ai preposti (4 ore, con aggiornamento biennale): riconoscimento dei segnali di disagio nei collaboratori, tecniche di ascolto attivo, gestione dei conflitti, comunicazione del cambiamento, ruolo del responsabile nella prevenzione dello SLC.
- Formazione al Gruppo di Gestione della Valutazione (8 ore, alla prima costituzione + aggiornamento biennale): metodologia INAIL, utilizzo della checklist, conduzione dei focus group, analisi dei risultati, definizione delle azioni correttive.
- Sensibilizzazione annuale: campagne informative sui temi del benessere organizzativo, della conciliazione vita-lavoro e della gestione dello stress, integrate con le iniziative del Piano Strategico PdG e D&I.

16. Monitoraggio e aggiornamento

La valutazione del rischio SLC è aggiornata con le seguenti cadenze: biennale per i gruppi omogenei a rischio basso; annuale per i gruppi omogenei a rischio medio o alto; entro 6 mesi dall'adozione di azioni correttive (rivalutazione di efficacia); entro 12 mesi dal closing di ogni operazione di acquisizione (valutazione del gruppo omogeneo neo-acquisito); in occasione di modifiche organizzative significative (riorganizzazioni, variazioni di organico superiori al 20%, cambiamenti di sede, introduzione di nuove tecnologie). I risultati della valutazione sono documentati nel DVR, comunicati ai lavoratori in forma aggregata e trasmessi al Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002) come input per il miglioramento continuo.

17. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	RSPP	MC	P&C	RSGI	Resp.str.	RLS
Costituzione Gruppo Gestione	R	C	C	I	I	C
Valutazione preliminare	R	R	C	C	C	C
Valutazione approfondita	R	R	R	C	C	C
Definizione azioni correttive	R	C	R	C	C	C
Sorveglianza sanitaria SLC	I	R	I	I	I	I
Sportello ascolto psicologico	I	C	R	I	I	I
Formazione SLC	R	C	R	I	I	I
Aggiornamento DVR	R	C	I	C	I	I
Reporting Riesame Direzione	R	C	C	R	I	I

18. Indicatori di processo

Completezza valutazione SLC: percentuale di gruppi omogenei valutati nei termini previsti. Obiettivo: 100%.

Livello di rischio per gruppo omogeneo: distribuzione dei gruppi per livello (basso/medio/alto). Obiettivo: 100% basso o medio con azioni in corso.

Tasso di risposta ai questionari (fase approfondita): obiettivo: almeno 70% per validità statistica.

Azioni correttive chiuse nei termini: percentuale di azioni correttive completate entro la scadenza pianificata. Obiettivo: almeno 90%.

Accessi allo sportello di ascolto: numero di accessi per trimestre (dato aggregato e anonimo). Monitoraggio trend.

Formazione SLC erogata: percentuale di responsabili e preposti formati. Obiettivo: 100% entro 12 mesi.

Variazione eventi sentinella: trend degli indicatori oggettivi (assenze, turnover, infortuni) per gruppo omogeneo. Obiettivo: trend stabile o in miglioramento.

19. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani